

ANNALES EVCP 2009-2024 GERIATRIE



Ce que tu trouveras ici

Ce document rassemble toutes les annales officielles disponibles sur le site du CNG et même parfois plus !
Un excellent point de départ pour t'entraîner, repérer les thématiques récurrentes et comprendre la logique du concours.

Mais attention : les sujets seuls ne suffisent pas.



Pour progresser vraiment, il faut des corrections détaillées les
et des rappels pédagogiques structurés, basés sur dernières recommandations.



Pour aller plus loin

Si tu veux accéder à la version corrigée complète, avec :

- les explications item par item
- les rappels de cours actualisés
- les références officielles



rends-toi dès maintenant sur www.prepevc.fr

Tu y retrouveras :

- Nos formations EVC complètes (voie interne & externe)
- Des banques de QCM et QROC corrigés par spécialité
- Des suivis personnalisés avec des praticiens hospitaliers



Ne laisse pas ta réussite au hasard

Les lauréats ne sont pas les plus "chanceux".

Ce sont ceux qui ont compris comment s'entraîner intelligemment, avec la bonne méthode et les bons outils.

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2009

Sujet :

Madame C. Marguerite 82 ans, veuve vit seule dans un appartement au premier étage sans ascenseur et ne reçoit aucune aide. Elle a 3 enfants qu'elle voit régulièrement, mais qui habitent chacun à plus de 50 km. Elle a été scolarisée jusqu'à 14 ans et par la suite elle a été ouvrière d'usine.

Dans ses antécédents on note une cholécystectomie, une hystérectomie totale à 42 ans, une coxarthrose non opérée très invalidante (marche avec une canne, et une HTA. Elle reçoit le traitement suivant :

Lasilix 20mg (furosémide) 1 cp le matin Amlor 5mg
(amlodipine) 1 cp matin et soir Avlocardyl 40mg
(propanolol) 1/2 cp matin et soir Stilnox (zolpidem)
1 cp le soir au coucher Tahor 10mg (atorvastatine)
1 cp le matin Dafalgan 500mg (paracétamol) 3 cp
Atarax 25mg (hydroxyzine) ½ cp matin et soir

Elle est adressée aux urgences pour chutes à répétition.

A l'examen, Mme C. présente un signe du pli cutané. Elle est bien orientée dans le temps et l'espace. Le poids est de 45 kg et elle mesure 1.60m. La TA est à 9/7 cmHg. Le poignet

gauche est douloureux et légèrement oedématié. L'examen clinique est normal par ailleurs. L'électrocardiogramme montre un rythme sinusal à 55 avec un espace QT à 0,36 seconde.

Les résultats biologiques montrent:

Leucocytes : 5,300 Giga/L

Plaquettes : 225 Giga/L

Hémoglobine: 9 g/dL

Hématocrite 28%

VGM 88 μ 3

Réticulocytes 20 Giga/L

Urée 10 mmol/L (N : 2.5-6.7)

Créatininémie 120 μ mol/L

Albumine : 30 g/L

Ferritine 200 μ g/L (N : 10-237)

CRP <5 mg/L

La radiographie du poignet gauche montre une fracture de type Pouteau Colles non déplacée. Le chirurgien pose une attelle plâtrée et préconise 3 semaines d'immobilisation.

Vous décidez de l'hospitaliser.

1°) Quels sont les facteurs favorisant cette chute ? Quelle est la cause la plus probable ?

2°) En fonction de la biologie fournie quelle est la cause la plus probable de cette anémie ? Argumentez.

Avant d'envisager un retour à domicile vous effectuez une évaluation gériatrique :

- 3°) Quels examens neuropsychologiques simples effectuez-vous pour évaluer ses fonctions cognitives ?
- 4°) Quels sont les arguments en faveur d'un syndrome de fragilité chez cette patiente?
- 5°) En raison de cette fracture quelle affection osseuse évoquez-vous ? Argumentez.
Quels examens complémentaires et quelle prise en charge détaillée proposez-vous?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2011

Sujet :

Un homme de 85 ans chute dans la rue (chute mécanique) sans perte de connaissance. Il est tombé de tout son long. Il est amené par les pompiers au SAU. A l'interrogatoire le patient est bien orienté, répond de façon cohérente. Il est en bon état général. Il a comme antécédents une arythmie chronique lente traitée par Previscan® (Fluindione), le dernier INR date de deux mois, il était à 2,5 ; une gonarthrose bilatérale, une HTA bien équilibrée traitée par CoAprovel® (hydrochlorothiazide 25 mg, irbésartan 150 mg). Il dit avoir été traité pour une bronchite, il y a dix jours, par Rulid® (roxithromycine).

Il a un hématome de la face externe de la cuisse droite sans impotence fonctionnelle. L'auscultation pulmonaire est normale, le pouls est irrégulier à 85 battements par mn, la TA est à 120/70 mm Hg. Le reste de l'examen clinique est normal. Il pèse 75 Kg pour 1,72 m. Les radiographies du bassin et du fémur sont normales.

L'ECG retrouve une arythmie par fibrillation atriale, sans autre anomalie.

- 1- Quels sont les 4 examens biologiques indispensables à réaliser dans l'immédiat ?
- 2- L'INR revient à 5,2. Comment pouvez-vous expliquer ce résultat ?

- 3- Quelle est votre conduite à tenir dans l'immédiat vis à vis de cet INR?
- 4- Quels sont les éléments cliniques à surveiller dans les heures à venir ?
- 5- Quels sont les éléments biologiques à surveiller dans les 24 heures à venir ?
- 6- L'évolution immédiate est satisfaisante, le malade sort. Au troisième jour son médecin traitant vous l'adresse de nouveau car il le trouve pâle, asthénique et ralenti. L'examen neurologique est normal, l'hématome de la cuisse est stable. Quel examen radiologique demandez-vous en urgence ? Justifiez votre réponse.
- 7- Cet examen est normal. L'INR est à 2,5. La numération montre une Hb à 10,2 g/dL, VGM 74 micron³, Plaquettes 420 000/mm³, leucocytes 6700/mm³ avec une formule normale. Commentez ces résultats.
- 8- Quels examens biologiques demandez-vous ?
- 9- Quelles explorations demandez-vous ?
- 10- Le patient devant regagner son domicile, quels conseils donnez-vous à votre patient vis à vis du traitement par Fluindione ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2012

Sujet :

Monsieur A., âgé de 78 ans, a une cardiopathie hypertensive et un antécédent d'accident ischémique transitoire survenu il y a 2 ans.

Il est traité par un inhibiteur de l'enzyme de conversion (Perindopril – 2mg/j), un diurétique (Furosémide – 40mg/j) et Acide acétylsalicylique 160mg/j. De

plus, il prend un hypnotique le soir depuis des années pour des insomnies.

Son médecin traitant l'adresse au service des urgences pour un état d'agitation d'apparition brutale, entrecoupé de périodes de somnolence évoluant depuis 48 heures environ. Il tient des propos incohérents. Il y a 5 jours, le médecin avait été appelé pour une broncho-pneumopathie fébrile, justifiant la prescription d'un traitement antibiotique par Ofloxacine 200mg 2 fois par jour.

Question n°1 :

- a)** Comment s'appelle un tel syndrome clinique ?
- b)** Dans ce contexte, quelle(s) étiologie(s) peut-on évoquer à son origine ?

A l'admission au service des urgences, Monsieur A. est somnolent, la température est de 37,5°, son pouls est régulier à 104/min, sa pression artérielle est de 105/65mmHg. Il pèse 65 kg. Sa langue est sèche, l'abdomen est souple et indolore à la palpation, sans globe vésical. L'auscultation pulmonaire montre un foyer de crépitations basal droit. L'examen neurologique ne montre pas de signe de localisation. La saturation à l'air ambiant est à 90%.

Le bilan biologique montre une leucocytose à 12.600/mm³, dont 90% de polynucléaires neutrophiles. La CRP est à 186mg/l. La glycémie est à 7 mmol/l. La recherche d'antigénurie de légionelle est négative. La fonction rénale montre une créatinine à 258µmol/l (Clcréat à 27 ml/min) et une urée à 30,5mmol/l. La natrémie est à 154mmol/l.

Question n°2 :

- a)** Comment interprétez-vous les anomalies cliniques et les résultats biologiques ?
- b)** Quels autres examens complémentaires demandez-vous en urgence ? Justifiez vos propositions
- c)** Quelles sont les prescriptions médicales et la surveillance que vous préconisez ?

Après une amélioration initiale, on constate l'apparition de diarrhées séro-sanglantes à forte odeur, au 9e jour d'hospitalisation.

Question n°3 :

- a)** Quelle est l'hypothèse diagnostique ? Décrivez votre démarche de confirmation de cette hypothèse
- b)** Décrivez la prise en charge que vous instituez
- c)** Indiquez les critères de normalisation et d'arrêt des mesures de la prise en charge

Au 15e jour d'hospitalisation, Monsieur A. a récupéré dans la plupart des éléments symptomatologiques présents au début : les signes respiratoires ont disparu, les diarrhées sont interrompues, l'état mental est revenu à la situation antérieure, l'appétit reprend.

Mais il est affaibli, il a du mal à se laver et à s'habiller, il se lève avec peine et a du mal à tenir sur ses jambes. Quand on le met dans un fauteuil il « glisse » et se retrouve comme dans une chaise longue.

Question n°4 :

- a)** Citez le nom de ce syndrome clinique.
- b)** Quelle prise en charge proposez-vous ? Décrivez les modalités, sachant qu'il ne va pas pouvoir rester dans le service de médecine.

Au terme du parcours hospitalier, Monsieur A. a modérément récupéré. Il reste instable à la marche avec des risques de chutes, il doit être aidé pour la toilette et l'habillage. Son épouse a le souhait de le reprendre à domicile, mais exprime le besoin d'aide pour les soins d'hygiène et aussi pour l'entretien du logement.

Question°5 :

- a)** Décrivez les aides et les soins que l'on peut mettre en place pour Monsieur A. et leurs conditions de mise en œuvre et de financement.
- b)** Décrivez les aides que l'on peut mettre en place pour aider le couple dans l'entretien du logement et leurs conditions de mise en œuvre et de financement.

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2013

Sujet :

Un homme de 83 ans a chuté à 2 reprises au cours de la semaine. Il s'agit d'un patient diabétique qui réalise lui-même le schéma à 2 injections d'insuline NPH 20 U le matin et 10 U le soir. Il est suivi pour une fibrillation atriale et est anticoagulé par warfarine 1 mg/j, une HTA traitée par perindopril 2,5 mg/j, amlodipine 10mg/j, et par l'

introduction récente d'hydrochlorothiazide 25 mg/j. Il est connu pour une cataracte bilatérale pour laquelle il a refusé la chirurgie

Le médecin traitant est appelé au domicile.

L'épouse rapporte que le patient prend de lui-même de l'oxazepam pour une anxiété. Elle précise le déroulement des chutes. La première est survenue en pleine nuit alors qu'il quittait son lit pour aller uriner. La seconde chute est survenue dans l'escalier. Il a trébuché sur un carton.

L'examen clinique ne montre pas de déficit neurologique ni de signe de fracture. Le patient n'est pas algique mais ne répond pas toujours de manière adaptée aux questions. La TA est à 120/70.

QUESTION N°1

Quelles hypothèses peut-on formuler pour expliquer les chutes ?

QUESTION N°2

Le patient est adressé à l'hôpital. L'examen est inchangé. L'ECG confirme une fibrillation atriale à 80/min. La glycémie capillaire est normale.

Quel examen complémentaire demandez-vous en urgence (1 seul) ?

QUESTION N°3

Cet examen est normal. Les résultats biologiques sont les suivants : Natrémie : 150 mmol/L, kaliémie:4,5 mmol/L, créatininémie 130 µmol/L, débit de filtration glomérulaire à 49mL/min (MDRD),urée 15 mmol/L, protidémie à 78 g/L, glycémie : 1,2 g/L (6,6 mmol/L). Hémoglobine:15,0g/dL, hématocrite 50%, INR : 2,2. Analysez et interprétez ces résultats.

QUESTION N°4

Rédigez votre prescription pour les 24 premières heures (hors surveillance).

QUESTION N°5

Le patient est transféré en gériatrie. Il n'est plus confus. Les anomalies biologiques sont corrigées. Son poids est de 60 kg pour 180 cm. Le patient ne consomme que la moitié de ses plateaux. Quel est votre diagnostic ? Justifiez.

QUESTION N°6

Citez deux examens biologiques pertinents pour étayer votre diagnostic ?

QUESTION N°7

Vous lerevoyez 3 mois après sa sortie de l'hôpital. Son épouse rapporte une aggravation des troubles de la mémoire et des épisodes de désorientation qui préexistaient à l'hospitalisation. L'ordonnance est identique à celle de sortie et une infirmière assure la bonne observance. Quels tests cognitifs de débrouillage réalisez-vous en consultation ?

QUESTION N°8

Quelles erreurs à cette évaluation vous orienteraient vers un trouble cognitif hippocampique ?

QUESTION N°9

Quel score module le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2014

Sujet :

Mme C, 87 ans, est hospitalisée dans votre service de médecine aiguë gériatrique après un passage rapide aux urgences pour troubles de la conscience et altération de l'état général récents.

Dansses antécédents on retient :

- une maladie d'Alzheimer modérée à sévère
- un diabète non insulino dépendant
- une hypertension artérielle
- une insuffisance veineuse chronique
- un ulcère gastroduodénal
- un syndrome anxio-dépressif ancien
-
-

Elle vit à domicile avec son époux et un dispositif d'aide comprenant une infirmière à domicile le matin et une aide ménagère. Elle est en perte d'autonomie mais faisait encore quelques pas avec sa canne.

Son traitement actuel comporte :

Nicardipine (LOXEN) 50 LP 2 par jour

Isinopril (ZESTRIL) 5 1 par jour

Irbesartan hydrochlorothiazide (COAPROVEL) 150/12,5 1 par jour

Rilmédine (HYPERIUM) 1 par jour

Esomeprazole 40 (INEXIUM) 1 par jour

Alprazolam (XANAX) 0.25 3 par jour

Galantamine (REMINYLP) 16 mg

Mémantine (EBIXA) 20 1 par jour

Paroxétine (DEROXAT) 20 mg 1 par jour

Metformine (GLUCOPHAGE) (850 mg, 2 par jour

Hydroxysine 100 ½ deux fois par jour.

À l'admission dans le service, la patiente est non communicante et somnolente. L'examen neurologique ne montre pas de signe de focalisation. On retrouve une pression artérielle à 90 / 60 mm Hg, une fréquence cardiaque à 110/ mn, une fréquence respiratoire à 30/mn, une fièvre à 38° et un état de déshydratation clinique. L'auscultation objective un foyer pulmonaire de crépitations en base gauche. Le sondage urinaire réalisé aux urgences retrouve des urines foncées.

La biologie des urgences donne les résultats suivants :

Natrémie : 168 mmol/l

Kaliémie : 4 mmol/l

Urée : 25 mmol/l

Protides : 78 g/l

Créatininémie : 160 mmol/l

Glycémie : 22 mmol/l (4 grammes/l)

GB 11800, taux d'hémoglobine: 11,8 g /dl

CRP 150 mg/l

Question N°1 :

Quelles sont vos 5 hypothèses diagnostiques à ce stade de la prise en charge ?

Question N°2 :

Le complément de résultats biologique montre une osmolarité à 358 mosmol/l.

Quel diagnostic retenez vous ?

Décrivez la cascade des événements ayant amené à cette situation clinique.

Question N°3 :

Quel sont les examens complémentaires utiles pour compléter ce bilan initial ?

Question N°4 :

Quels sont les risques de complications aiguës de la pathologie qui a justifié l'hospitalisation ?

Question N°5 :

Quelles thérapeutiques médicamenteuses proposez vous ?

Question N° 6 :

Au delà du traitement médicamenteux, rédigez les prescriptions associées en termes de surveillance et de soins infirmiers dans les 48 heures.

Question N° 7 :

Dans le contexte de cette urgence chez une patiente présentant une démence vous avez proposé une limitation et/ou arrêt des thérapeutiques actives.
Quelles sont les conditions nécessaires pour cette procédure ?
Quel pourrait en être le contenu chez cette patiente ?

Question N° 8 :

Au 5^{ème} jour, l'évolution est favorable sur le plan clinique. Le bilan biologique de contrôle montre une hémoglobine à 7.8 g/dl et un volume globulaire moyen (VGM) à 78 μ 3

Citez deux examens biologiques indispensables au diagnostic étiologique.

Quelle exploration paraclinique est à programmer ?

Quelle(s) autre(s) thérapeutique(s) sont à prescrire ?

Question N° 9 :

A J 15, la patiente est stabilisée et quitte l'unité de court séjour. La clearance de la créatinine est à 28ml/mn.

A partir de l'ordonnance d'entrée, quelles sont les thérapeutiques que vous ne reconduisez pas et celle(s) que vous instaurez ou maintenez ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2015

Sujet :

Un homme de 86 ans, veuf depuis un an, sans enfants, vit seul à domicile sans aides professionnelles. Lors de sa visite médicale, le médecin est alerté par une perte de poids de 7kg au cours de l'année passée et un mauvais état d'hygiène.

Il vous l'adresse en consultation de gériatrie. Dans ses antécédents : une HTA, une cardiopathie ischémique, un diabète de type 2, une diverticulose colique, un adénome de la prostate, une artériopathie des membres inférieurs. Vous l'examinez : poids est de 63kgs pour 1,80m, TA 110/75 mmHg, Fc 55/mn,

Son traitement : Amlodipine(Amlor[®]),hydro-chlorothiazine,
Bisoprolol(Bisoce[®]),gliclazide(diamicron[®]),
permixon [®],esomeprazol (inexium [®]).

Question n°1

Comment définissez-vous l'état nutritionnel, sur quels arguments ?

Question n°2

Quelles sont les étiologies que vous pouvez déjà suspecter devant ce tableau ?

Question n°3

Quelle évaluation clinique de la situation nutritionnelle proposez-vous ?

Les examens biologiques pratiqués en ville montrent :

Albuminémie : 32g/l – Hb1C : 6,2% - Urée : 10mmol/l – Créatinine : 15μmol/l –
Clairance de la créatinine 28 ml/mn - NFS normale – CRP<5mg/l –

Na⁺ 128mmol/l – Glycémie à jeun : 4,5mmol/l

Question 4 : Analysez et commentez les résultats biologiques au regard de la situation et du traitement

Question 5 : Quels sont les trois domaines les plus pertinents à explorer durant cette consultation, avec quels outils ?

Question 6 : Quelles modifications de son traitement suggérez-vous ?

Question 7 : Au terme de la consultation gériatrique quelles interventions proposez-vous pour optimiser le maintien à domicile ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2016

Sujet :

Une femme de 91 ans est retrouvée par ses voisins (inquiets de ne pas voir les volets ouverts depuis la veille) à terre dans sa cuisine, habillée, la table de la veille non débarrassée.

Elle présente des troubles cognitifs non évalués. Elle est hypertendue chronique.

Elle présente un syndrome anxiodépressif avec troubles du sommeil suite au décès de son époux depuis deux ans.

Elle est consciente, elle n'a pas de déficit moteur. La température est à 36°C. Elle présente des frissons, elle a une pollakiurie, une toux grasse. Il existe des crépitants à l'auscultation en base droite. Elle présente des douleurs lombaires intenses.

Son ordonnance comporte :

- Paroxétine (inhibiteur de la recapture de la sérotonine)
- Bisoprolol (bêta-bloquant)
- Amlodipine (inhibiteur calcique)
- Hydroxyzine (anti-H1)
- Alprazolam (benzodiazépine)
- Zolpidem (hypnotique apparenté aux benzodiazépines)

L'ECG est sinusal, sans changement par rapport à sa dernière hospitalisation.

Question n°1

D'après les informations dont vous disposez, quels sont les facteurs qui ont pu favoriser la chute chez cette patiente ?

Question n°2

Aux urgences le bilan biologique retrouve : natrémie 150 mmol/l, kaliémie 4,4 mmol/l, urée 16,6 mmol/l (1g/l), créatininémie 200 micromoles/l (22,6 mg/l), glycémie 6mmol/l (1.2g/l), protidémie 70g/l hémoglobine 11g/dl, globules blancs : 11500.103/l.

Quel bilan biologique complémentaire en première intention prescrivez-vous ?

Question n°3

Quels examens d'imagerie devez-vous réaliser en justifiant chacun de vos choix ?

Question n°4

Quelles hypothèses diagnostiques faites vous à ce stade ?

Question n°5

Donnez les grands principes des traitements médicamenteux que vous prescrivez en urgence en fonction des hypothèses diagnostiques précédentes ?

Question n°6

En raison de douleurs, pendant la nuit, l'interne de garde a prescrit en plus de vos traitements de la morphine. Le lendemain la patiente présente une confusion aiguë et une douleur abdominale.

Quelles sont les causes les plus probables de la confusion chez cette patiente ?

Question n°7

Au bout de quelques jours, la patiente va mieux et désire rentrer à domicile. La patiente reste instable à la marche et doit être aidée pour la toilette et

l'habillage.

Quelles mesures envisagez-vous pour le retour à domicile ? Donnez quelques exemples.

Modifiez-vous l'ordonnance d'entrée ? Argumentez.

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2017

Sujet:1

L'ensemble des sujets est à traiter

Mme AR âgée de 85 ans est amenée aux urgences par sa fille pour un malaise sans traumatisme ni perte de connaissance. Elle a déjà présenté un malaise léger un mois auparavant qui n'avait pas donné lieu à une hospitalisation. Elle décrit également une dyspnée d'effort depuis 1 an d'aggravation progressive.

Dans les antécédents, on note une hypertension artérielle, un diabète de type 2 et un syndrome anxio-dépressif.

Son traitement comporte Amlodipine 5mg/j, Ramipril 5mg/j , Metformine 1 g 2fois/jour, Oxazepam 10mg/j, mirtazapine 15 mg/j au coucher.

A l'examen clinique, elle n'a ni syndrome confusionnel, ni symptôme neurologique. Il n'y a pas de signe clinique d'insuffisance cardiaque.

L'auscultation cardiaque est évocatrice d'un souffle de rétrécissement aortique.

Question N° 1 :

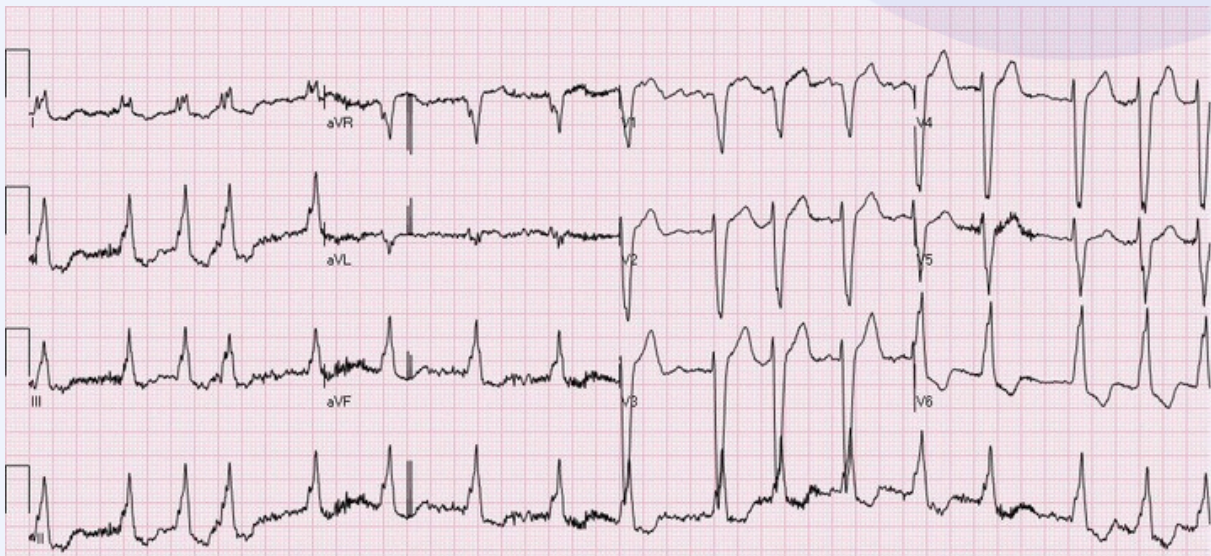
Citez les signes auscultatoires évocateurs du rétrécissement aortique.

Question N° 2 :

Dans ce contexte de malaise, quelle donnée de l'examen physique manque-t-il ?

Question N° 3 :

Voici l'ECG de cette patiente : interprétez-le ?



Question N° 4 :

Quels autres examens paracliniques demandez-vous ?

Question N° 5 :

Les résultats des examens biologiques sont normaux. Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ? Justifiez.

Question N° 6 :

Au décours de votre prise en charge, la patiente est bien équilibrée sur le plan thérapeutique mais présente toujours une dyspnée à l'effort. L'échographie qui est réalisée montre une surface aortique à 0,8 cm². Quelle mesure thérapeutique proposez-vous ? Justifiez

Après prise en charge adaptée, la patiente est améliorée. Elle est revue 1 an plus tard car elle est à nouveau dyspnéique. Son hémogramme est le suivant :

Hémoglobine : 7,5g/dl
VGM 78 micro³
plaquettes 428 000/mm³
GB 8000 /mm³
réticulocytes 1%

Question N° 7 :

Interprétez l'hémogramme ?

Question N° 8 :

Quels examens complémentaires demandez-vous ?

Question N° 9 :

En attendant les résultats des examens : quelles sont les deux principales mesures thérapeutiques à prendre pour cette patiente ?

Monsieur P âgé de 85 ans est adressé en médecine gériatrique à la demande de son médecin traitant pour troubles de l'équilibre. Il vit à domicile avec son épouse.

Ses troubles de l'équilibre s'aggravent progressivement depuis 6 mois. Sa femme dit que sa marche est instable. Il a présenté 2 chutes au cours du dernier mois sans conséquence traumatique. Le patient est décrit comme ralenti par son épouse ; il a réduit ses activités, il est moins motivé ; son épouse rapporte que les tâches élaborées sont plus difficiles, par exemple lire son journal, payer ses factures. Les activités de la vie quotidienne sont préservées hormis une incontinence urinaire apparue depuis 3 mois d'après son épouse.

A l'interrogatoire, le patient a du mal à se concentrer et avoir une attention soutenue.

A l'examen clinique on ne relève pas de déficit neurologique focalisé, on retrouve une astasie-abasie avec tendance à la rétropulsion, il n'y a pas de syndrome extrapyramidal, ni de syndrome vestibulaire ni cérébelleux, ni de signe en faveur d'une neuropathie périphérique. Le MMSE est à 24/30. Les fluences verbales alphabétique et catégorielle sont altérées (8 et 4 mots). Il n'y

a pas de trouble de la mémoire épisodique; le test des 5 mots de Dubois est le suivant : score 10/10 et score pondéré 16/20.

Dans ses antécédents, on note un diabète de type 2, une hypertension artérielle, une Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs stade 2. Son traitement habituel comprend : METFORMINE 500 mg matin et soir, VALSARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE 160/12,5 mg, PANTOPRAZOLE 40 mg. Ses constantes sont les suivantes : PA 130/80 mmHg, FC 70 bpm, spO2 98%, température 36,8°C, glycémie capillaire 1 g/L.

Question N° 1 :

Donnez 3 hypothèses diagnostiques pour expliquer les troubles de l'équilibre et sur quels arguments ?

Question N° 2 :

Compléter l'examen clinique ?

Question N° 3 :

Quels examens para cliniques proposez-vous et que recherchez-vous ?

Question N° 4 :

Pour conforter votre diagnostic principal, vous envisagez un geste à visée diagnostique et thérapeutique. Lequel ?

À l'issue de son hospitalisation en court séjour gériatrique, le patient est orienté en Soins de suite gériatriques pour rééducation de l'équilibre et de la marche. Pendant son séjour en SSR, un traitement par PAROXÉTINE est introduit.

Après 1 semaine d'hospitalisation en SSR il développe une fièvre à 38°C en rapport avec une pneumopathie basale droite qui est traitée par AMOXICILINE-ACIDE CLAVULANIQUE.

3 jours après la fin de l'antibiothérapie il présente plusieurs épisodes diarrhéiques.

Question N° 5 :

Quelle est votre hypothèse diagnostique ? Quels sont les facteurs favorisant cet épisode ? Quel examen complémentaire demandez-vous ? Quelle est votre prise en charge ?

Question N° 6 :

Les problèmes infectieux sont résolus. Vous constatez une natrémie à 127 mmol/l alors qu'elle était normale jusqu'à présent. Votre examen clinique ne trouve pas d'œdème.

Quels mécanismes peuvent être à l'origine du trouble ionique observé ?

Question N° 7 :

Après la réhydratation ce patient conserve une natrémie à 130 mmol/l, quel est votre diagnostic ?

Quel examen paraclinique demandez-vous ? Quelle est votre prise en charge ?

L'hyponatrémie est corrigée. Le patient s'alimente peu. Il a perdu 3,5 kgs en 2 semaines. Il mesure 1m72 et pèse 60 kgs. Son taux d'albumine est à 33 g/l.

Question N°8:

Quel est votre diagnostic ? Sur quels arguments ? Quels éléments devez-vous prendre en compte pour interpréter le taux d'albumine ?

Question N° 9:

Quelle prise en charge proposez-vous ? Graduer cette prise en charge.

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2018 TOUS LES SUJETSSONT A TRAITER

Sujet:1

Une femme âgée de 76 ans a des antécédents de :

- Cardiomyopathie hypertensive
- Dyslipidémie
- Gonarthrose bilatérale.

Elle vous est adressée par son médecin pour une asthénie. La patiente présente une diarrhée fécale, non glairo-sanglante et des douleurs abdominales péri-ombilicales. Il existe un amaigrissement de 5 kg durant les six derniers mois.

Le traitement comporte : ranipril (2,5 mg/j), aténolol (1,25 mg/j), simvastatine (20 mg/j), tramadol (50 mg x 3 /j), paracétamol (2 gr/j) et kétoprofène (100 mg/j).

La patiente est veuve depuis 6 mois et vit seule en appartement au 1er étage. Son ADL (Activity Daily Life) est à 6/6 et l'IADL (Instrument Activity Daily Life) à 3/8.

À l'examen clinique :

- * Le poids est à 42 kg pour 1,58 m, sa pression artérielle à 120/80 mmHg,
- * il existe une pâleur cutanéomuqueuse et des douleurs abdominales provoquées par la palpation de la région péri-ombilicale, sans contracture ni défense.

La patiente vous montre également les résultats récents d'examens biologiques:

*NFS: hémoglobine : 9,1 g/dL, VGM : 79 μm^3 , hématocrite : 23%, leucocytes totaux : 7,7 G/L, plaquettes : 207.000/ mm^3 ;

*réticulocytes : 70.000/ mm^3 ,

*C-réactive protéine < 5 mg/L ;

*urée : 3,4 mmol/L, créatinine : 61 $\mu\text{mol/L}$, natrémie : 136 mmol/L, kaliémie : 4,1 mmol/L, protidémie : 54 g/L ; TGO 24 UI/l, TGP 25 UI/l, GGT 35 U/l.

*glycémie à jeun : 5 mmol/L.

Question N°1 :

Interprétez les résultats de l'hémogramme :

Question N°2 :

Au vu des résultats biologiques, quels sont les 2 examens biologiques que vous demandez ?

Question N°3 :

Calculez l'Indice de masse corporelle (IMC) et comment l'interprétez-vous ?

Question N°4 :

Comment évaluez-vous l'état nutritionnel, sur le plan clinique, de cette patiente ?

Question N°5 :

Quels sont les 2 principaux signes à l'examen clinique que vous recherchez en faveur d'une dénutrition ?

Question N°6 :

Quels sont les 4 signes de gravité biologiques de dénutrition que vous recherchez chez votre patiente ?

Question N°7 :

Quels sont les 8 facteurs de risque de dénutrition à rechercher chez cette patiente ?

Question N°8 :

Parmi les médicaments pris par la patiente, quels sont les 2 potentiellement responsables d'un amaigrissement ?

Question N°9 :

Votre bilan comportant scanner thoraco-abdomino-pelvien, gastroscopie et colonoscopie (avec biopsies étagées), coproculture et examen parasitologique des selles et bilan endocrinien, s'est révélé normal. Vous reprenez l'interrogatoire de la patiente qui indique la présence de myalgies depuis plus d'un an. Quel médicament suspectez-vous ?

Question N°10 :

Lors de son retour à domicile, quels sont les 5 propositions que vous préconisez à votre patiente pour améliorer son état nutritionnel, en accord avec les recommandations de l'HAS (Haute Autorité de Santé) ?

Sujet : 2

Une femme de 85 ans, vivant seule, habituellement autonome est amenée au SAU par sa fille. Cette dernière signale une agitation inhabituelle, elle ne la reconnaît plus, tient des propos incohérents et elle est désorientée.

L'IDE d'accueil retrouve une fièvre à 38°5, la patiente est normotendue, présente un dextro à 3 g/l, une bonne saturation pulpaire. Il y a de vagues douleurs abdominales signalées.

Antécédents :

ACFA anticoagulée

Diabète non insulino-dépendant

Cancer du sein en rémission

Polyarthrose

Traitement:

PREVISCAN (FLUINDIONE)

BISOCE 5 mg (BISOPROLOL)

EFFERALGAN (PARACETAMOL) CODEINE 500 mgX3/j

LEXOMIL (BROMAZEPAM): ¼ de cp au coucher et si besoin en journée

METFORMINE (GLUCOPHAGE) 500 mg: 1-1-1

Question N° 1 :

Dans les données du cas clinique, quelles sont celles qui évoquent une confusion ?

Question N° 2 :

Citez 2 éléments d'anamnèse complémentaires à rechercher par l'interrogatoire de la fille?

Question N° 3 :

Citez 6 éléments cliniques connus ou à rechercher pouvant être à l'origine du syndrome confusionnel ?

Question N° 4 :

On retrouve une bandelette urinaire positive, la NFS montre 17000 GB/mm³ et une CRP à 200 mg/l

On évoque en priorité une infection urinaire fébrile.

Vous souhaitez néanmoins éliminer une autre cause à la confusion. Quels examens biologiques et radiologiques sont nécessaires (maximum 10)?

Question N° 5 :

Quelle classe d'antibiotiques prescrivez-vous ?

Question N° 6 :

Concernant le traitement du domicile, quelles modifications s'imposent d'emblée ?

Sujet:3

Monsieur T. 92 ans est adressé par son médecin traitant pour douleur du membre inférieur droit dans un contexte d'alitement depuis 3 jours pour des lombalgies mécaniques.

Ses antécédents comprennent une insuffisance rénale chronique (clairance de Cockcroft à 14 ml/mn), hypertension artérielle, tabagisme sévré.

Le traitement habituel comprend Amlodipine 10 mg (1 cp par jour).

Aux urgences : température 37,8°C, TA 110/60 mmHg, pouls 102/mn, SaO₂ = 95%, poids 63 kg.

A l'examen clinique, il existe un œdème du membre inférieur droit, les pouls périphériques sont perçus, l'auscultation cardiopulmonaire est normale.

Question N° 1 :

Quel est le diagnostic le plus probable ?

Question N° 2 :

Quel examen complémentaire demandez-vous pour confirmer le diagnostic ?

Question N° 3 :

Quel bilan biologique minimal (4 examens maximum) prescrivez-vous avant de débiter le traitement ?

Question N° 4 :

Quelle prise en charge immédiate préconisez-vous ?

Question N° 5 :

Quels sont les trois principaux paramètres biologiques à surveiller durant la première semaine ?

Sujet : 4

Madame G. 87 ans, veuve, vivant seule sans enfant, retrouvée au sol le matin par son aide ménagère à 10 heures. Elle est adressée aux urgences.

Antécédents :

Chutes à répétition

Diabète de type 2

Hypertension artérielle

Cataracte non opérée

Prothèse totale de genou

Dyslipidémie

Traitement actuel :

Bisoprolol 5 mg x1

Nicardipine 20 mgx1

Rilmenidine 1 mgx1

Metformine 1000 mgx3

Repaglinide 1 mgx3

Zopiclone 7,5 mg le soir

Atorvastatine 40 mgx1

La patiente explique qu'elle est tombée, vers 2 heures du matin en se levant du lit en se rendant aux toilettes. A l'examen clinique, elle présente une impotence fonctionnelle et une douleur du poignet gauche. Le reste de l'examen clinique est normal. Température corporelle 35,8°C, TA=100/60 mmHg, pouls 55/mn, poids 51 kg.

Question N° 1 :

Quelle est la définition de la chute à répétition ?

Question N° 2 :

Quels sont les 3 éléments en faveur d'une chute grave chez cette patiente ?

Question N° 3 :

Quels sont les 3 examens paracliniques à prescrire en 1ère intention (hors biologie) ?

Question N° 4 : Sur le plan biologique, on constate : CPK = 12 x N , clairance de la créatinine= 35 ml/mn (Cockcroft), NFS normale, natrémie=146 mmol/l, urée = 0,6 g/l, glycémie = 0,6 g/l, albuminémie = 30 g/l, CRP= 5 mg/l. Quelles sont les anomalies dans ces examens biologiques ? **Question N° 5 :**

Quels sont les médicaments à réévaluer chez cette patiente ? Justifiez.

Question N° 6 :

Quelle conséquence psychologique est à craindre ?

GERIATRIE

Epreuve de vérification des connaissances pratiques 2019

Sujet :

Une patiente de 91 ans vous est adressée par son médecin traitant, dans le service d'accueil des urgences dans lequel vous travaillez. Elle présente depuis 48 heures un tableau clinique associant agitation, hétéro-agressivité envers son auxiliaire de vie qu'elle semble ne plus reconnaître. Elle ne sait pas où elle se trouve et ne peut pas vous donner la date du jour. Ses propos sont incohérents.

Question N° 1 :

Vous suspectez un syndrome confusionnel. Quels sont les éléments dans l'énoncé en faveur du diagnostic ?

Question N°2

Quels autres éléments cliniques recherchez-vous en faveur du diagnostic de confusion selon le DSM-5 ?

Question N°3

Quelles sont les formes cliniques de confusion que vous connaissez ?

Question N°4

Vous avez joint le médecin traitant qui vous a précisé les antécédents de la patiente : hypertension artérielle, diabète de type 2, incontinence urinaire, dépression. Son traitement actuel associe : hydrochlorothiazide + valsartan (COTAREG ®), paroxétine (DEROXAT ®), oxybutynine (DITROPAN ®), oméprazole (MOPRAL ®), gliclazide (DIAMICRON ®), hydroxyzine (ATARAX ®). L'hydroxyzine a été introduite depuis quelques jours, après plusieurs essais infructueux de traitements pour ses troubles du sommeil.

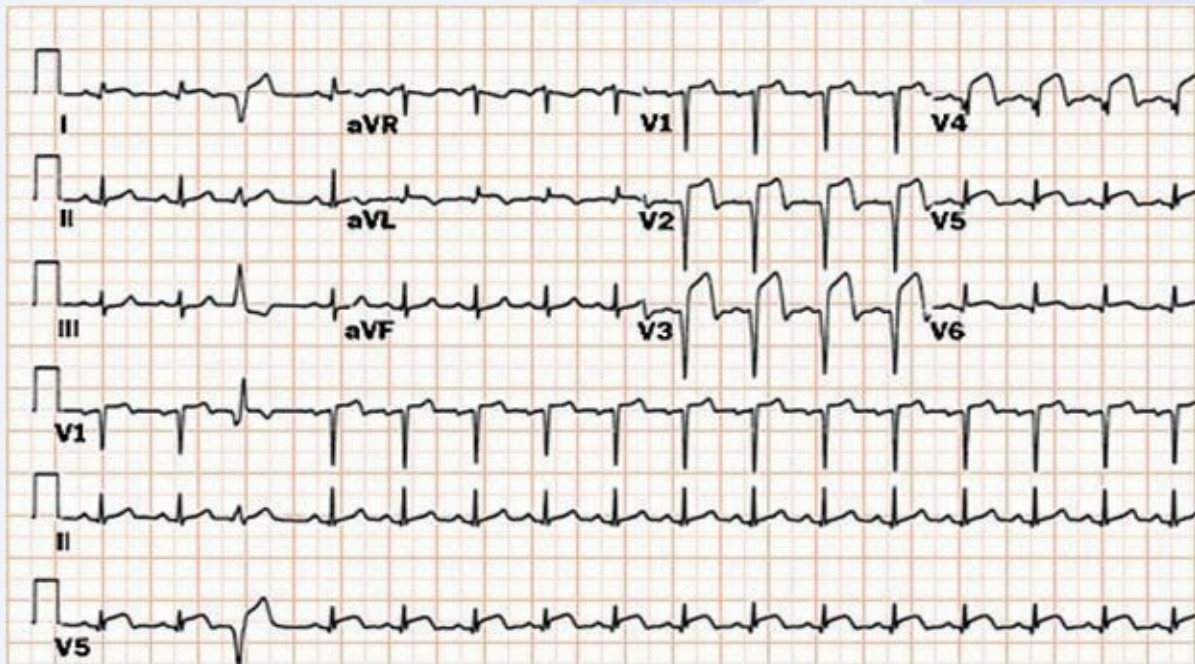
Détaillez les facteurs précipitants de la confusion, à la lumière de ces nouvelles informations, et détaillez les causes de chaque facteur précipitant.

Question N°5

Les constantes de la patiente sont les suivantes : T° = 36.8 °C ; PA = 102/65 mmHg ; pouls 95 / min régulier. L'examen neurologique est considéré comme normal. L'auscultation cardiopulmonaire est normale. Comment complétez-vous votre examen dans le box des urgences ? Justifiez.

Question N°6

L'infirmière vous apporte l'ECG de votre patiente, présenté ci-dessous. Quelle est votre interprétation du tracé ?



Question N°7

Quel est votre diagnostic ?

Question N°8

Compte-tenu de l'ensemble de l'observation, quels examens biologiques demandez-vous en urgence ?

Question N°9

Après une prise en charge adaptée de la pathologie cardiaque, votre patiente est transférée dans votre unité de gériatrie aiguë. Vous avez corrigé tous les troubles somatiques. Néanmoins, elle est toujours confuse, très agitée et anxieuse.

Après 48 heures passées dans le service et la mise en œuvre de mesures non-médicamenteuses habituelles, l'équipe soignante de votre service vous demande de prescrire un traitement. Sur quels arguments décideriez-vous de l'introduction d'un traitement médicamenteux ?

Quelle classe thérapeutique et selon quelles modalités ?

Question N°10

Vous revoyez la patiente en consultation six mois après la guérison de son syndrome confusionnel. Elle est accompagnée de sa fille, qui s'inquiète d'« oublis fréquents de rendez-vous » et la trouve triste. Elle n'a pas repris ses activités de loisirs et sort moins de chez elle. Quel(s) diagnostic(s) syndromique(s) évoquez-vous avec ces éléments.

EVCP 2021

Vous êtes appelé auprès d'une femme de 91 ans résidente d'EHPAD car les soignants la trouvent somnolente. Ses antécédents sont dominés par un syndrome démentiel sévère avec symptômes comportementaux. Elle est entrée en EHPAD il y a 18 mois. Le diagnostic étiologique évoqué est une origine probablement mixte. Elle est hypertendue de longue date. Depuis son entrée en EHPAD à laquelle elle était opposée, elle est opposante aux soins. Elle présente de troubles du sommeil qu'elle avait déjà à domicile. Elle a évoqué sa propre mort à plusieurs reprises et a été mise sous antidépresseurs, il y a 6 mois. Elle a maigri progressivement depuis son entrée en EHPAD (60 kg il y a 7 mois ; 54 kg sur son dernier poids il y a 1 mois). Elle ne communique que très peu et le plus souvent est très difficile à comprendre du fait de troubles du langage. Il y a 15 jours, elle a fait une bronchite sans signe de gravité traitée par antibiotique pendant 6 jours (amoxicilline et acide clavulanique). Depuis 48h, elle ne déambule plus comme elle a l'habitude de le faire. Elle est consciente, elle n'a pas de déficit moteur. La température est à 36°C. Elle a un foyer de crépitants en base droite et une toux grasse. Elle refuse de prendre ses médicaments. Elle est effectivement somnolente quand vous arrivez, mais devient agitée lorsque vous commencez à l'examiner. Son discours est incompréhensible. La pression artérielle est à 95/65 mmHg, le pouls à 90/min, la saturation en air ambiant à 90%. Le reste de son examen clinique est inchangé. L'ECG est sinusal, sans changement par rapport à sa dernière hospitalisation.

Son ordonnance comporte depuis plus de 6 mois sans modification (en dehors du traitement antibiotique) :

Alprazolam (benzodiazépine)
Paroxétine (inhibiteur de la recapture de la sérotonine)
Amlodipine (inhibiteur calcique)
Furosémide (diurétique de l'anse)
Acide acétylsalicylique (antiplaquettaire)
Omeprazole (inhibiteur de la pompe à protons)
Macrogol (laxatif osmotique)
Zolpidem (hypnotique apparenté aux benzodiazépines)
Risperidone (antipsychotique)

Question 1

Quels sont les diagnostics que l'on peut envisager d'évoquer ici ? (ne pas citer les antécédents). Pour chacun d'entre eux : arguments en faveur

Vous avez demandé un bilan biologique en urgence qui montre : natrémie 153 mmol/l, kaliémie 4,4 mmol/l, urée 16,6 mmol/l (1g/l), créatininémie 115 micromoles/l (22,6 mg/l), glycémie 6 mmol/l (1.2g/l), protidémie 63 g/l hémoglobine 14 g/dl, globules blancs : 11500.103/l. CRP 250 mg/l. RT-PCR pour le SARS-CoV2 : négative.

Question 2 : Sur la base de ces résultats, quels sont les diagnostics que vous retenir ?

Pour chacun d'entre eux, citez les arguments en faveur

Question 3 : Quelle décision allez-vous prendre concernant l'alimentation, l'hydratation et le traitement médicamenteux de cette patiente sur les prochaines 24 heures ?

Question 4 Au bout de quelques jours, la patiente va mieux, la question se pose de reprendre son traitement antérieur. Le reprenez-vous de façon inchangée ? Quelles modifications éventuelles de ce traitement proposez-vous ? Pourquoi ?

Question 5 : La patiente enchaîne finalement 3 épisodes du même type en l'espace de deux mois. La question se pose de limiter les soins actifs. Quelles sont les étapes du processus d'une décision de limitation des thérapeutiques actives ?

Sujet 2

Vous êtes appelé auprès d'une résidente de l'EHPAD dont vous êtes le médecin coordonnateur pour une femme de 90 ans admise dans l'EHPAD la semaine dernière qui est agitée et brutalise le personnel soignant. Elle a pour antécédent une hypertension artérielle et un syndrome dépressif associé à un syndrome démentiel de type maladie d'Alzheimer au stade modéré. Elle est maintenue attachée à son fauteuil avec un harnais de contention, car elle cherche à se lever et à déambuler et le personnel craint qu'elle fasse une chute. Le traitement habituel comporte amlodipine 10 mg/j (antagoniste des canaux calciques) et escitalopram 10 mg/j (inhibiteur de la recapture de la sérotonine). L'examen montre une température à 38°, une PA à 146/80 mmHg, une fréquence cardiaque à 94 / mn, des sueurs, une SaO2 à 94%. L'examen clinique est difficile en raison de l'agitation.

Question 1 : Face à l'agitation de cette résidente que préconisez-vous dans un premier temps ?

La fille, aidant de la résidente, demande à vous rencontrer car elle est inquiète du brusque changement de son état de santé. Elle vous signale que depuis son entrée dans l'EHPAD, sa mère se plaint de ne plus dormir la nuit et qu'on ne lui donne plus le somnifère qu'elle prenait chaque soir depuis des années. Elle vous indique que sa mère ne souhaitait pas vraiment entrer en EHPAD. Elle se sent très coupable et se demande si sa mère ne fait pas une aggravation brutale de sa dépression.

Question 2 : Ces nouveaux éléments orientent-ils votre diagnostic et la prise en charge de la résidente ?

EPREUVE DE VERIFICATION DES CONNAISSANCES PRATIQUES 2023

Sujet 1

Vous voyez un homme de 95 ans, qui consulte dans un contexte de chutes à répétition.

Il signale également une difficulté nette à se relever de son fauteuil.

Il s'agit d'un patient avec une hypertension artérielle sous amlodipine, une fibrillation atriale paroxystique sous Amiodarone et Rivaroxaban.

Ce patient, ancien employé dans les transmissions de télégramme après un certificat d'études primaires, est marié et a 2 fils. Il vit à domicile.

Il y a 6 mois, il a consulté un neurologue de ville pour un ralentissement global. Un traitement par L-dopa a été introduit devant la suspicion d'une maladie de Parkinson idiopathique.

De façon plus récente, une dysurie et une pollakiurie ont justifié l'introduction d'un traitement par alpha bloquant.

QUESTION 1 : Concernant les chutes à répétition, quels mécanismes en termes de facteurs précipitants pouvez-vous évoquer chez ce patient ? Justifiez vos réponses.

QUESTION 2 :

Vous avez identifié une hypotension orthostatique sans accélération du pouls lors de la consultation.

Comment qualifiez-vous l'hypotension orthostatique de ce patient ?

QUESTION 3 :

Par ailleurs, le fils du patient vous signale qu'il le trouve très ralenti depuis environ 1 mois. Il a été obligé de s'occuper de ses papiers et de ses comptes pour la première fois avec plusieurs oublis d'échéances. Il y a des alternances de moments de franche lucidité et d'autres de grande incohérence le plus souvent dans la même journée. Votre examen neurologique confirme un syndrome parkinsonien prédominant à droite. L'évaluation cognitive de débrouillage en consultation montre un MMS à 24/30 (rappel 2/3, calcul 1/5, figure 0/1). Devant les troubles cognitifs, vous vous posez la question d'une démence à corps de Lewy. Quels sont les arguments en faveur dans cette observation ?

QUESTION 4 :

Vous avez fait réaliser une IRM cérébrale. Expliquez ce que vous recherchez avec cet examen.

Après une évaluation neuro-psychologique complète et l'ensemble des examens complémentaires, vous vous orientez vers le diagnostic de démence à corps de Lewy. On décide de mettre en place un traitement par inhibiteur de l'acétylcholinestérase.

QUESTION 5 :

Quelle prise en charge non médicamenteuse (médicale et sociale) allez- vous proposer ?

QUESTION 6 :

Vous mettez en œuvre l'ensemble de cette prise en charge.

Quelques mois après, lors d'une consultation de suivi, l'épouse du patient se plaint de recevoir des coups de la part de son mari alors qu'il dort, ce qui la gêne terriblement. Quelle hypothèse diagnostique formulez –vous pour ce trouble ?

QUESTION 7 :

Vous continuez à suivre ce patient et sur l'année passée, son état reste stable de son avis et celui de son épouse.

Environ 3 mois après votre dernière consultation, il est hospitalisé aux urgences. A l'arrivée aux urgences, un ECG est réalisé par l'infirmière.

QUESTION 8 :

Votre interne a beaucoup de mal à examiner le patient qui ne se laisse pas faire mais il lui semble que la mobilité de l'hémicorps droit est globalement moins bonne. Il obtient un scanner cérébral en urgence, pensant à un accident vasculaire cérébral ischémique potentiellement d'origine embolique compte tenu de la fibrillation atriale connue. Le radiologue appelle avant même que le patient revienne dans le service pour vous demander de regarder les images du scanner sur le logiciel d'imagerie partagé dans l'hôpital. Voici une des coupes de ce scanner. Interprétez cette image de scanner cérébral.

Sujet 2

Vous hospitalisez en urgence en unité de court séjour gériatrique une patiente de 80 ans, amenée par son mari sur la demande de SOS médecin avec la lettre suivante : « Cher confrère, merci de voir Mme A. pour altération de l'état général. Ce matin, son mari nous a appelés car elle n'arrivait pas se réveiller. La glycémie capillaire était à 0,3g/l. Elle a reçu 3 ampoules de G30% en IV. La glycémie est remontée à 2 g/l. Merci de ce que vous pourrez faire pour elle »
Son mari vous indique ses antécédents :

- Diabète depuis 10 ans
- Hypertension artérielle depuis 10 ans également, avec une cardiopathie hypertensive
- Chirurgie de la cataracte des 2 yeux il y a 10 ans (c'est dans le bilan préopératoire qu'ont été découverts le diabète et l'HTA)
- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
- Coxarthrose droite pour laquelle elle a refusé l'intervention chirurgicale proposée il y a quelques années. Pendant les crises douloureuses, elle prend d'elle-même du diclofénac qui lui avait été prescrit il y a plusieurs années et c'est d'ailleurs le cas en ce moment.

Il vous confie la dernière ordonnance de son médecin généraliste :

- Gliclazide 30 LM : 3 cp le matin
- Hydrochlorothiazide : 12,5 mg/j
- Losartan : 50 mg/j
- Clopidogrel : 75mg/j

Et la dernière biologie, effectuée il y a 2 mois : HbA1C : 7,5%, créatinine : 110 umol/l (Clairance de la créatinine selon Cockcroft à 28 ml/mn)

A l'arrivée : poids : 50 kg, PA : 140/70 mm Hg, apyrétique, glycémie capillaire : 1,4g/l, Na : 140 mEq/l, K : 4,2 mEq/l, Créatininémie = : 160 umol/l (Clairance de la créatinine selon Cockcroft à 19 ml/mn)

QUESTION 1 :

Quelle mesure thérapeutique prescrivez-vous immédiatement et pourquoi ? Que décidez-vous de faire concernant les traitements habituels de la patiente ?

QUESTION 2 :

Quels sont les 2 mécanismes possibles de l'hypoglycémie initiale ?

QUESTION 3 :

Le traitement antidiabétique était-il adapté chez cette patiente et pourquoi ?

QUESTION 4 :

De quel trouble hydroélectrolytique souffre-t-elle et quel en est le mécanisme le plus probable ?

QUESTION 5 :

Après quelques jours, l'état de la patiente s'est amélioré. Vous commencez à préparer la sortie. La créatininémie est à 110 $\mu\text{mol/l}$ (Clairance de la créatinine selon Cockcroft 28 ml/min). Les glycémies sont entre 1,8 et 2,5 g/L.

Sans entrer dans les détails, quel type de traitement antidiabétique allez-vous prescrire. Justifiez votre choix. Comment encadrez-vous cette prescription ?

QUESTION 6 :

Lapression artérielle est en permanence entre 160/60 et 180/90 mmHg. Vous décidez de réintroduire l'ARA2. Quelle surveillance allez-vous prescrire ?

Sujet 3

Un homme de 94 ans est amené aux urgences par les pompiers après avoir été retrouvé au sol à son domicile par son aide-ménagère le matin même (elle était sans nouvelle de lui depuis 48 heures). Veuf sans enfant, il vit seul en pavillon, marche avec 1 canne quand il sort du domicile, car il est déjà tombé dehors à 3 reprises ces dernières années. Autonome pour les activités de la vie quotidienne, il bénéficie d'une aide – ménagère 3 heures/ semaine pour le ménage uniquement. Vous notez dans ses antécédents :

- Notion de troubles cognitifs légers non explorés
- Diabète de type 2 traité par metformine avec adjonction récente de repaglinide
- Hypertension artérielle traitée par ramipril et hydrochlorothiazide
- Fibrillation atriale sous rivaroxaban
- Gonarthrose gauche pour laquelle il prend régulièrement du tramadol
- Cataracte bilatérale non opérée
- Tabagisme sevré à 70 PA, exogénose non sevrée (4 verres de vin/jour)
- Difficultés de sommeil depuis plusieurs années expliquant la prise régulière de zopiclone

A l'examen :

- Température : 38,3° C, TA : 110/70 mmHg
- Bruits du cœur irréguliers, ECG : fibrillation atriale connue, fréquence cardiaque 100/min
- Score de Glasgow 12, confus et agité
- Réflexes rotuliens et achilléens non retrouvés
- Foyer de crépitants en base droite, saturation en oxygène 90% en air ambiant
- Sensibilité et matité à la percussion hypogastrique
- Rougeurs des 2 talons et dermabrasions diffuses le scanner cérébral est normal.

Dans le bilan biologique, vous notez : hémoglobine 17g/dl, leucocytes 18 Giga/mm³ dont polynucléaires 15 Giga/mm³, plaquettes 480 Giga/mm³, LDH à 4 fois la normale (4N), CPK 15N, urée 20 mmol/L, créatininémie 150 umol/L (clairance de créatinine évaluée à 21 ml/min avec la formule de Cockcroft), CRP 120mg/l, protides plasmatiques 80g/l, natrémie 149 mmol/L, kaliémie 4,2 mmol/L, glycémie 6 mmol/L, calcémie 2,35mmol/L.

QUESTION 1 :

Quels sont les facteurs prédisposants de chute que vous notez chez ce patient ?

QUESTION 2 :

Quels médicaments ont pu jouer un rôle dans la chute en tant que facteurs précipitants ? Précisez le ou les mécanisme (s) pour chacun.

QUESTION 3 :

En prenant en compte l'ensemble des informations cliniques et paracliniques, quelles complications immédiates de la chute identifiez – vous chez ce patient ?

QUESTION 4 :

Interprétez les résultats donnés de la numération formule sanguine. Si vous notez une ou des anomalies, donnez pour chacune l'explication qui vous paraît la plus probable.

QUESTION 5 :

Quelle est votre attitude pour chacun des médicaments du patient pour les 24 premières heures ?

QUESTION 6 :

Comment allez-vous réhydrater ce patient ? Détaillez (voie, type de soluté et principe pour déterminer le volume).

Sujet EVCP 2024 – Gériatrie
Sujet 1 :

Au titre de l'équipe mobile de gériatrie, vous êtes appelé pour donner votre avis sur une patiente de 87 ans venant de son domicile, hospitalisée depuis deux jours. Faute de place en service de médecine, elle a été admise en chirurgie. Le motif d'admission aux urgences : perte d'autonomie dans un contexte fébrile à 39°C.

Antécédents médicaux :

- Hypertension artérielle
- Diabète de type 2
- Aucune allergie connue

Traitement habituel :

- Metformine 1000 mg : 2 fois par jour
- Amlodipine 10 mg : 1 fois par jour
- Escitalopram 10 mg : 1 fois par jour
- Ésoméprazole 20 mg : 1 fois par jour
- Atorvastatine 20 mg : 1 fois par jour
- Aspirine 100 mg : 1 fois par jour

Question 1 :

Quelle précaution nécessite la prescription de metformine ?

Question 2 :

Commentez la prescription d'ésoméprazole.

Question 3 :

Face à l'élévation de la créatininémie, que recherchez-vous pour caractériser cette anomalie ?

Question 4 :

Comment interprétez-vous l'hypernatrémie ?

Question 5 :

Comment interprétez-vous l'élévation de la CRP en fonction des éléments biologiques et cliniques dont vous disposez ?

Question 4

Comment interprétez-vous l'hypernatrémie ?

Question 5

Comment interprétez-vous l'élévation de la CRP en fonction des éléments biologiques et cliniques dont vous disposez ?

Question 6

La fréquence respiratoire est à 26/min et la saturation en oxygène s'élève à 89 % en air ambiant. La patiente tousse et a des crépitations en base droite pulmonaire. Quels examens complémentaires prescrivez-vous ?

Question 7

Quelles sont les grandes lignes de la thérapeutique médicamenteuse pour les 24 premières heures ?

Question 8

Vous êtes de nouveau rappelé à J3 dans le service car après une amélioration initiale (disparition de la fièvre, normalisation du bilan biologique), la patiente a des troubles du comportement à type d'agressivité. Elle refuse les soins, a des propos incohérents, est très énervée et opposante, surtout l'après-midi et lors du début de la nuit. Elle a même failli fuguer à deux reprises.

L'équipe soignante a décidé de l'enfermer dans sa chambre et de mettre une contention abdominale la nuit au lit.

L'interne du service a prescrit de l'Haldol (Halopéridol) à raison de 10 gouttes x 3/jour et 2 prises supplémentaires si besoin.

L'équipe vous demande d'agir car ils « ne peuvent pas la garder ».

L'interne de chirurgie insiste sur le fait qu'elle n'a « rien à faire en chirurgie » et qu'il faut l'envoyer en EHPAD.

La fille que vous rencontrez vous dit que sa mère allait bien à la maison où elle vivait seule sans aide, qu'elle était toujours aimable et qu'elle ne la reconnaît plus. Parfois, elle avait tendance à l'appeler plusieurs fois de suite au téléphone pour savoir si sa fille allait bien venir la voir, mettant ceci sur le compte de son anxiété. Elle a dû l'aider cette année pour faire sa déclaration d'impôts.

Quel diagnostic évoquez-vous ? Sur quels arguments ?

Question 9

Quels facteurs précipitants identifiez-vous dans ce cas clinique ?

Question 10

Vous recherchez deux autres facteurs précipitants, très fréquents en gériatrie, lesquels ?

Question 11

Quelle est votre conduite thérapeutique ?

Question 12

Madame est sortie de l'hôpital, tous les psychotropes ont été arrêtés, et vous la recevez en consultation 6 mois plus tard. Vous notez une akinésie, elle marche à petits pas et sa fille rapporte 3 chutes le mois dernier. Sa fille dit qu'elle l'a appelée car elle voyait des chats dans sa cuisine et sa chambre alors qu'elle n'a pas d'animaux. Elle se plaint de faire des cauchemars et d'être tombée de son lit.

Quelle est votre hypothèse diagnostique ? Justifiez.

Sujet 2

Vous êtes le médecin coordonnateur d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

À propos d'une résidente âgée de 89 ans, admise en EHPAD depuis 18 mois en raison d'une altération cognitive rendant son maintien à domicile impossible.

Elle a pour antécédents une hypertension artérielle (HTA) et une maladie d'Alzheimer.

Elle est grabataire et dépendante de tiers dans tous les actes de la vie quotidienne.

Elle est classée groupe Iso-ressource GIR 1. Depuis 8 mois, elle est incapable d'interagir de façon adaptée.

Question 1

Le médecin généraliste dit qu'elle est au stade très sévère de sa maladie d'Alzheimer.

Qu'en pensez-vous ? Argumentez votre réponse.

Question 2

Elle pèse 80 kg pour 165 cm (IMC = 29,4 kg/m²).

Elle a maigri de 6 kg depuis son dernier épisode de pneumopathie il y a deux semaines.

Elle mange une demi-portion en salle à manger où elle est contentionnée à son fauteuil et a une hydratation sous-cutanée (500 mL de Glucosé 5 %).

Vous notez une amyotrophie au niveau des mains et des cuisses, et une rougeur au niveau du sacrum sans plaie.

Elle présente des troubles de la déglutition.
Installée au fauteuil, elle est incapable de se lever.
Le médecin généraliste, qui suit cette patiente, déclare :
« Avec un IMC à plus de 29, il n'y a pas de dénutrition. »
Qu'en pensez-vous ? Justifiez.

Question 3

Quels sont dans ce cas les mécanismes à l'origine de la dénutrition ? Justifiez.

Question 4

Sa fille, « très présente », s'inquiète de l'amaigrissement ainsi que de la diminution des ingesta.

Elle se demande si une nutrition par sonde ne serait pas adaptée.

Quels sont vos arguments contre une alimentation par voie entérale ?

Question 5

Vous constatez que cette patiente a une contention au fauteuil par une ceinture pelvienne, et vous apprenez qu'elle glisse sans cesse en avant avec un risque de chute.

Cliniquement, vous notez, à trois reprises durant votre observation, qu'elle se repositionne sur son siège en fronçant le front et les sourcils et en geignant.

Quelle prise en charge suggérez-vous globalement ?

Question 6

Quelques jours plus tard, l'infirmière vous sollicite pour appeler l'équipe mobile de soins palliatifs afin de redéfinir une prise en charge.

Quels sont les arguments pour faire appel à l'équipe mobile de soins palliatifs chez cette patiente ?